

1. Який тест є важливим елементом під час підготовки до реабілітації, оскільки дає можливість визначити готовність пацієнта до початку фізичних навантажень?

- A. Тест балансу Берг
- B. Тест 4-х квадратів
- C. Тест 2-хвилинної ходьби +
- D. Чотиристапний тест балансу
- E. Функціональний тест м'язів стегна

2. У семирічного хлопчика через 2 місяці після операції подовження ахіллового сухожилка під час огляду виявлено зменшення обсягу рухів у гомілковостопному суглобі. Батьки відзначають швидку втомлюваність під час ходьби та уникання активних рухів стопою. Укажіть оптимальний компонент програми фізичної терапії в цьому разі.

- A. Перехід до динамічних вправ із високим навантаженням у закритому кінематичному ланцюзі
- B. Включення активних і контрольованих пасивних рухів у межах протоколу післяопераційного ведення +
- C. Орієнтація втручання на загальну фізичну активність без локальної роботи з гомілковостопним суглобом
- D. Використання ізометричних скорочень м'язів гомілки як основного компонента програми
- E. Тимчасове припинення активного втручання з утриманням кінцівки у фіксованому положенні

3. Які реабілітаційні заходи рекомендовані пацієнтам після стабільно-функціонального остеосинтезу перелому шийки стегнової кістки?

- A. Берегти кульшовий і колінний суглоби, але активно застосовувати рухи здоровою ногою
- B. Пасивні рухи в колінному та кульшовому суглобах із 4-го дня після операції
- C. Терапевтичні вправи з 2-го дня після операції, ходьба на милицях із 5-6-го дня +
- D. Створити спокій для кінцівки протягом місяця на ортопедичній шині, але активні рухи в колінному суглобі проводити з 4-го дня після операції
- E. Суворий постільний режим протягом 2-х тижнів

4. Під час реабілітаційного обстеження чоловіка фізичний терапевт виявив ознаки правостороннього геміпарезу, що є причиною зниження мобільності пацієнта та рівня його побутових навичок. З анамнезу відомо: гостре порушення мозкового кровообігу півроку тому. Яку шкалу застосує фізичний терапевт для кількісної оцінки рухових навичок пацієнта?

- A. Модифіковану шкалу спастичності Ашворта
- B. Комітету медичних досліджень
- C. Оцінки моторики Рівермід
- D. Бартела +
- E. Для оцінки м'язової сили

5. Фізичний терапевт оцінює силу трапецієподібного м'яза. Пацієнт у положенні сидячи самотійно піднімає плечі вгору з максимальною амплітудою, але не може виконати рух, якщо фізичний терапевт чинить невеликий опір руховій дії. Визначте максимальний бал за ММТ.

- A. 3 +
- B. 5
- C. 4
- D. 1
- E. 2

6. Пацієнтка віком 34 роки звернулася зі скаргами на тривалий біль у поперековому відділі хребта внаслідок тривалого режиму роботи сидячи. Після завершення 8-тижневої програми реабілітації пацієнтка зазначила, що біль став набагато меншим і вона може довше сидіти без дискомфорту. Яке поняття використовується для контролю клінічної ефективності лікування, яку пацієнт сприймає як важливу і корисну?

- A. Валідність опитувальника
- B. Мінімальна чутливість до змін
- C. Мінімальна клінічно значуща різниця +
- D. Мінімальна клінічно виявлена зміна
- E. Надійність опитувальника

7. Фізичний терапевт, провівши тестування згиначів передпліччя ізометричним напруженням м'язів, виявив слабе та безболісне напруження. Про яке ймовірне ушкодження свідчить такий результат тестування?

- A. Ентезопатія
- B. Давні розриви м'яза (загоєний розтяг 3-го ступеня) +
- C. Міозит
- D. Розтягнення м'яза 1-2-го ступеня, тендиніт
- E. Розтягнення зв'язок 1-2-го ступеня

8. Пацієнт віком 58 років з погано компенсованим цукровим діабетом 2-го типу скаржиться на біль та поколювання в стопах. Об'єктивно виявлено: зниження вібраційної чутливості на рівні гомілковостопних суглобів та сили м'язів-згиначів стопи, при ході — опускання стопи. Який захід фізичної терапії є патогенетично обґрунтованим на цьому етапі реабілітації?

- A. Кінезіотейпування литкових м'язів
- B. Електростимуляція м'язів передньої поверхні гомілки та стоп
- C. Масаж нижніх кінцівок за класичною методикою
- D. Тренування ходи з ортезом та правильного перекатування стопи +
- E. Силові вправи на тренажерах для нижніх кінцівок

9. Фізичний терапевт проводить навантажувальний тест (тредміл-тест) для пацієнта на етапі амбулаторної реабілітації. Протокол передбачає поступове збільшення інтенсивності кожні 3 хв. Отримано такі дані моніторингу — у спокої: ЧСС — 72/хв, АТ — 120/80 мм рт. ст.; 3-тя хвилина (1-й ступінь): ЧСС — 95/хв, АТ — 135/82 мм рт. ст., 6-та хвилина (2-й ступінь): ЧСС — 118/хв, АТ — 115/80 мм рт. ст. Пацієнт скаржиться на помірну втому, задишка за шкалою Борга — 3 бали (помірна). Яка дія фізичного терапевта є доцільною в цьому разі?

- A. негайно припинити тестування та перевести пацієнта в положення лежачи або сидячи, оскільки спостерігається гіпотензія навантаження +
- B. Збільшити кут нахилу тредмілу, щоб стимулювати роботу серця та підвищити систолічний тиск до адекватних значень
- C. Продовжити тестування на поточному рівні навантаження (без підвищення), оскільки зниження тиску пов'язане зі зменшенням периферичного опору судин (вазодилатацією)

- D. Зменшити швидкість тредмілу та запропонувати пацієнту випити води, розцінивши реакцію як ознаку дегідратації
- E. Продовжити тестування, але ретельно моніторити сатурацію кисню (SpO₂), оскільки зниження АТ є допустимим фізіологічним явищем при аеробному навантаженні

10. Які зміни дихальних шумів можна виявити в пацієнта з плевральним випотом під час аускультації легень?

- A. Бронхіальне дихання
- B. Крепітацію
- C. Сухі хрипи
- D. Відсутність дихальних шумів +
- E. Вологі хрипи

11. Які реабілітаційні заходи рекомендовані пацієнтам після стабільно-функціонального остеосинтезу перелому шийки стегнової кістки?

- A. Берегти кульшовий і колінний суглоби, але активно застосовувати рухи здоровою ногою
- B. Пасивні рухи в колінному та кульшовому суглобах із 4-го дня після операції
- C. Створити спокій для кінцівки протягом місяця на ортопедичній шині, але активні рухи в колінному суглобі проводити з 4-го дня після операції
- D. Терапевтичні вправи з 2-го дня після операції, ходьба на милицях із 5-6-го дня +
- E. Суворий постільний режим протягом 2-х тижнів

12. У постінсультного пацієнта з лівобічним геміпарезом — пушер-синдром, що ускладнює тренування функціональної ходьби. Яке втручання доцільно насамперед включити до програми фізичної терапії з урахуванням цього синдрому?

- A. Вправи зі стабілізації погляду з рухами голови
- B. Баланс-тренінг на платформах
- C. Тренування з візуальним зворотним зв'язком +
- D. —
- E. Тренування подвійних завдань

13. Пацієнт віком 52 роки звернувся до фізичного терапевта зі скаргами на біль у правому плечовому суглобі, що триває 3 місяці та посилюється при піднятті руки вгору та заведенні її за спину. Попередній діагноз — імпіджмент-синдром плечового суглоба. Який спеціальний клінічний тест доцільно використати для підтвердження цього діагнозу?

- A. Тест Гокінса-Кеннеді (Hawkins-Kennedy test) +
- B. Тест Лермітта (Lhermitte's sign)
- C. Тест Томпсона (Thompson test)
- D. Тест Ласега
- E. Тест Спіда (Speed's test)

14. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на зниження сили м'язів лівої кисті. Із анамнезу відомо, що 4 місяці тому після попадання ракети в будівлю пацієнту уламками затисло кінцівку в ділянці плеча. За цей час сила м'язів збільшилася, але відновилася не повністю. Під час об'єктивного обстеження встановлено, що пацієнт може рухати пальцями кисті, але сила м'язів знижена до 4/5 балів за ММТ. Який вид пошкодження периферичних нервів, найімовірніше, спостерігається в пацієнта?

- A. Перерізання
- B. Невротмезис
- C. Невропраксія
- D. Аксонотмезис +
- E. Розтягнення

15. Пацієнт із перенесеним інсультом, геміпарезом та силою м'язів верхньої кінцівки 1-2 бали скаржиться на помірний біль у плечі паретичної кінцівки. До індивідуальної програми фізичної терапії включено такі втручання, як позиціонування та обережне ставлення до паретичної кінцівки, підтримуючі пов'язки для руки під час переміщення і ходьби пацієнта. Із якою метою зазначені втручання залучені до програми фізичної терапії пацієнта в цьому разі?

- A. Попередження контрактури
- B. Підвищення сили м'язів
- C. Зниження спастичності
- D. —

Е. Профілактики сублюксації +

16. Пацієнт віком 40 років, військовослужбовець, після отримання мінно-вибухового поранення та ампутації лівої верхньої кінцівки на рівні передпліччя скаржиться на пекучий біль високої інтенсивності в пальцях лівої верхньої кінцівки, за шкалою ВАШ — 7-8 балів, що не табується середньодобовими дозами знеболювального. Який вид болю, найімовірніше, спостерігається в пацієнта?

А. Ноципластичний

В. Фантомний +

С. Ішемічний

Д. Запальний

Е. Міофасціальний

17. Визначте метод, який застосовується в передчасно народжених немовлят із моменту народження та об'єктивно впливає на регуляцію серцебиття та дихання, підтримку температури тіла, покращення набору ваги.

А. Хендлінг

В. Мама-кенгуру +

С. Метод сухої імерсії

Д. Позиціонування

Е. Трансферинг

18. Пацієнт з транстібіальною ампутацією лівої нижньої кінцівки перебуває на ранньому післяопераційному етапі реабілітації. Які реабілітаційні інтервенції є ефективними для контролю набряку, прискорення загоювання кукси та ранньої підготовки до протезування?

А. Жорсткі або напівжорсткі пов'язки, позиціонування, менеджмент рубця, терапевтичні вправи +

В. М'які пов'язки, менеджмент рубця, терапевтичні вправи, низькочастотна магнітотерапія

С. М'які пов'язки, позиціонування, терапевтичні вправи, масаж

Д. Жорсткі або напівжорсткі пов'язки, менеджмент рубця, низькочастотна магнітотерапія

Е. М'які пов'язки, менеджмент рубця, терапевтичні вправи, масаж

19. Пацієнт віком 32 роки із встановленим діагнозом: анкілозуючий спондиліт, скаржиться на ранішню скутість та нічний біль у попереково-крижовому відділі хребта. Пацієнт проходить курс амбулаторної реабілітації. Фізичний терапевт підбирає оптимальне реабілітаційне втручання та визначає спосіб контролю його ефективності. Який варіант буде найбільш обґрунтованим?

- A. Вправи на мобілізацію хребта та контроль за допомогою тесту Шобера +
- B. Заняття на біговій доріжці у швидкому темпі та контроль за допомогою сатурації
- C. Застосування теплових процедур на поперековий відділ та оцінка ефективності та контроль рівня болю за шкалою ВАШ
- D. Витяжіння хребта та контроль рівня артеріального тиску
- E. Силові тренування та контроль ефективності шляхом вимірювання частоти серцевих скорочень

20. Дворічному хлопчику проведено хірургічну корекцію дефекту міжшлуночкової перегородки. Яке реабілітаційне втручання зможе запобігти контрактурам і покращити легеневий статус у гострий період реабілітації в цьому разі?

- A. Контрольований кашель
- B. Дихальні вправи
- C. Постукування та вібрація
- D. Позиціонування +
- E. Стимулююча спірометрія

21. До фізичного терапевта звернувся пацієнт віком 45 років зі скаргами на хронічний біль у поперековому відділі хребта, що триває понад 3 місяці. Пацієнт зазначає, що біль суттєво обмежує його повсякденну активність: він не може піднімати важкі предмети, відчуває труднощі при тривалому сидінні (понад 15 хв) та має порушення сну через дискомфорт. Фахівцю необхідно об'єктивізувати вплив болю на повсякденне функціонування пацієнта для оцінки ефективності майбутнього втручання. Який із нижченаведених інструментів є міжнародно визнаним «золотим стандартом» для специфічної оцінки ступеня порушення життєдіяльності саме в цій категорії пацієнтів?

- A. Короткий опитувальник болю МакГілла
- B. Візуально-аналогова шкала
- C. Загальний опитувальник здоров'я SF-36

D. Опитувальник інвалідності Освестрі +

E. Шкала тривоги та депресії HADS

22. Фізичну працездатність пацієнтів, які хворіють на бронхіальну астму, оцінюють шляхом індивідуальної можливості витримувати фізичне навантаження. Який метод застосовують у цьому разі?

A. Спірографії

B. Спірометрії

C. Купера

D. Велоергометрії +

E. Стрельнікової

23. Пацієнт віком 67 років, 4 тижні після ішемічного інсульту в правій півкулі, має лівобічний геміпарез, помірні порушення рівноваги, користується чотириопорною палицею під наглядом і має легкий когнітивний дефіцит. Під час планування домашньої реабілітації фізичний терапевт оцінює бар'єри та полегшувальні фактори за МКФ. Який фактор навколишнього середовища є найважливішим для безпеки й дотримання програми вдома?

A. Наявність поручнів у місці проживання

B. Відстань від дому пацієнта до найближчого спеціалізованого реабілітаційного центру

C. Доступність спортивних майданчиків або тренажерів на подвір'ї

D. Наявність друкованих інформаційних матеріалів про інсульт у домі

E. Наявність та готовність доглядальників асистувати під час виконання вправ +

24. Чоловік віком 48 років скаржиться на біль та обмеження амплітуди розгинання в поперековій ділянці хребта. Ознак червоних та жовтих прапорців не виявлено. Які вправи порекомендує фізичний терапевт пацієнту?

A. Статичні для м'язів живота

B. На розгинання м'язів поперекового відділу хребта +

C. На розтягнення м'язів поперекового відділу хребта

D. Нахили тулуба вперед до 45°

E. З нахилом тулуба вперед до 15-20°

25. Пацієнт після інсульту має гарний реабілітаційний потенціал і технічно може пересуватися по квартирі з ходунками. Проте його дружина постійно наполягає на використанні крісла колісного, мотивуючи це страхом, що пацієнт «впаде й зламає шийку стегна». Пацієнт, уникаючи конфлікту, погоджується, хоча це знижує його рівень активності. Як згідно з МКФ класифікується поведінка дружини?

- A. Бар'єр (e410) — Індивідуальні погляди та ставлення найближчих родичів +
- B. Бар'єр (b770) — Функції патерну ходи
- C. Фасилітатор (e310) — Підтримка та стосунки з найближчими родичами
- D. Нейтральний фактор, оскільки він не впливає на структури організму
- E. Бар'єр (e580) — Політика, пов'язана зі сферою охорони здоров'я

26. Яку модель ходьби потрібно використовувати на ранніх етапах реабілітації після оперативного втручання у зв'язку з ендопротезуванням кульшового суглоба?

- A. Модель ходьби з ролатором
- B. Двоточкову модель ходьби з милицями
- C. Модель ходьби з ходунками
- D. Триточкову модель ходьби з милицями +
- E. Чотириточкову модель ходьби з милицями

27. Після перенесеного COVID-19 у пацієнта спостерігається дуже низька толерантність до навантаження. Яка фізична активність рекомендована цьому пацієнтові в перші 6 тижнів після виписки?

- A. Зменшити свою повсякденну діяльність і виконувати фізичні вправи низької інтенсивності
- B. Виконувати свою повсякденну діяльність і додаткові фізичні вправи низької та середньої інтенсивності з короткими інтервалами +
- C. Виконувати свою повсякденну діяльність і додаткові фізичні вправи низької інтенсивності тричі на добу
- D. Виконувати свою повсякденну діяльність і додаткові фізичні вправи середньої інтенсивності
- E. Зменшити свою повсякденну діяльність і виконувати фізичні вправи низької інтенсивності двічі на добу

28. Пацієнтка віком 42 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 39,2°C протягом 4 днів, кашель з мокротинням, біль у правій половині грудної клітки, задишку та тахіпное (28/хв). Під час фізикального обстеження виявлено: нижче кута правої лопатки перкуторно тупий звук та ослаблене везикулярне дихання з крепітацією при аускультції. Який додатковий метод обстеження є обов'язковим для встановлення остаточного діагнозу?

- A. Комп'ютерна томографія
- B. Спірографія
- C. Рентгенографія +
- D. Пікфлоуметрія
- E. Магнітно-резонансна томографія

29. Для визначення ступеня сили в пацієнтів із патологічними проблемами широко застосовується ММТ. Що з нижченаведеного правильно визначає спосіб проведення мануального м'язового тестування чотириголового м'яза стегна на оцінку «4»?

- A. Сидячи на столі, гомілка звисає, коліно зігнуте на 90°, контралатеральне стегно відведене і стопа знаходиться на стільці. Пацієнт згинає ногу в коліні на повну амплітуду проти помірного опору
- B. Сидячи на столі, гомілка звисає, коліно зігнуте на 90°, контралатеральне стегно відведене і стопа знаходиться на стільці. Пацієнт розгинає коліно на повну амплітуду проти помірного опору +
- C. Лежачи, нога зігнута під кутом 90°. Пацієнт розгинає коліно на повну амплітуду проти помірного опору
- D.
- E. Сидячи на столі, гомілка звисає, коліно зігнуте на 90°, контралатеральне стегно відведене і стопа знаходиться на стільці. Пацієнт піднімає стегно на повну амплітуду проти помірного опору

30. Чоловіку віком 60 років з ішемічною хворобою серця призначили тест на толерантність до фізичного навантаження. Що є протипоказанням до проведення навантажувального тестування?

- A. Поодинокі екстрасистоли
- B. Ожиріння II ступеня
- C. Гостра респіраторна інфекція +

D. Артеріальна гіпертензія I ступеня

E. Серцева недостатність I ступеня

31. Пацієнту після ГПМК треба обстежити ризик падіння. Який тест буде оптимальним для використання, якщо в доступі є коридор довжиною 5 м?

A. Тест «Встань та йди» +

B. Динамічний індекс ходьби

C. Тест 20 присідань

D. Тест 6-хвилинної ходьби

E. Тест Френчай

32. У постінсультного пацієнта з лівобічним геміпарезом — пушер-синдром, що ускладнює тренування функціональної ходьби. Яке втручання доцільно насамперед включити до програми фізичної терапії з урахуванням цього синдрому?

A. Тренування з візуальним зворотним зв'язком +

B. Баланс-тренінг на платформах

C.

D. Вправи зі стабілізації погляду з рухами голови

E. Тренування подвійних завдань

33. Пацієнт віком 67 років, 4 тижні після ішемічного інсульту в правій півкулі, має лівобічний геміпарез, помірні порушення рівноваги, користується чотириопорною палицею під наглядом і має легкий когнітивний дефіцит. Під час планування домашньої реабілітації фізичний терапевт оцінює бар'єри та полегшувальні фактори за МКФ. Який фактор навколишнього середовища є найважливішим для безпеки й дотримання програми вдома?

A. Наявність друкованих інформаційних матеріалів про інсульт у домі

B. Наявність поручнів у місці проживання

C. Доступність спортивних майданчиків або тренажерів на подвір'ї

D. Відстань від дому пацієнта до найближчого спеціалізованого реабілітаційного центру

E. Наявність та готовність доглядальників асистувати під час виконання вправ +

34. З метою повернення професійного футболіста до змагального спорту через 7 місяців після реконструкції зв'язок колінного суглоба фізичний терапевт вирішив включити тренування на пропріоцепцію та динамічну стабілізацію. Яке втручання є прогресивним та функціонально-специфічним на цьому етапі реабілітації?

- A. Мобілізація надколінка в медіальному напрямку
- B. Пліометричні стрибки зі зміною напрямку та приземленням на нестабільній поверхні +
- C. Виконання присідань на двох ногах з вагою власного тіла
- D. Вправи на рівновагу на нерухомій поверхні
- E. Вправи на ізометричне скорочення чотириголового м'яза в закритому кінематичному ланцюзі

35. Які зміни дихальних шумів можна виявити в пацієнта з плевральним випотом під час аускультації легень?

- A. Вологі хрипи
- B. Відсутність дихальних шумів +
- C. Сухі хрипи
- D. Бронхіальне дихання
- E. Крепітацію

36. На 14-ий день після перенесеного інсульту пацієнт здійснює активні рухи кистю та пальцями проти сили тяжіння. Спастичність за шкалою Ашворта - 1 бал. Пацієнт має запит на відновлення функцій захоплення та переміщення об'єктів ураженою рукою. Яку стратегію втручання потрібно обрати в цьому разі?

- A. Застосування пасивно-активних терапевтичних вправ
- B. Багаторазове завдання-орієнтоване тренування +
- C. Пасивні рухи кисті та пальців із підтримкою роботизованого пристрою
- D. Використання подвійних завдань
- E. Використання лонгети/ортеза для кисті поза межами сеансів терапії

37. Пацієнтові віком 32 роки з передньонижнім вивихом плечової кістки після знеболення проведено вправлення вивиху. Яку фіксацію доцільно виконати пацієнту?

- A. Фіксацію косинкою
- B. Гіпсову лонгету від травмованого до променево-зап'ясткового суглоба
- C. Скелетне витягнення за плечову кістку
- D. Пов'язку Дезо +
- E. Торако-брахіальну гіпсову пов'язку

38. Чоловік віком 45 років, що хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет упродовж 8-ми років, звернувся до приватного центру реабілітації з метою підвищення толерантності до фізичних навантажень. Які ознаки та симптоми гіпоглікемії можуть бути виявлені в пацієнта під час оперативного контролю на занятті за програмою аеробних вправ?

- A. Слабкість, підвищена пітливість +
- B. Підвищення температури тіла, почервоніння обличчя
- C. Маніакальний настрій, підвищення рівня енергії
- D. Втома, агресивна поведінка
- E. Ністагм, дзвін у вухах

39. Дворічному хлопчику проведено хірургічну корекцію дефекту міжшлуночкової перегородки. Яке реабілітаційне втручання зможе запобігти контрактурам і покращити легеневий статус у гострий період реабілітації в цьому разі?

- A. Позиціонування +
- B. Стимулююча спірометрія
- C. Постукування та вібрація
- D. Дихальні вправи
- E. Контрольований кашель

40. Яка клінічна ознака не вимагає припинення тестування на фізичну працездатність?

- A. Напад стенокардії за відсутності змін на ЕКГ
- B. Зниження систолічного артеріального тиску на 25%
- C. Безпричинна відмова пацієнта від продовження тестування
- D. Підвищення систолічного тиску на 25% +

Е. Напад стенокардії з наявністю змін на ЕКГ

41. У чому полягає одна з ролей фізичного терапевта в нейрореабілітації військовослужбовців із легкою ЧМТ?

- А. Пояснення щодо адаптації нервової системи та її потреби в дозованому навантаженні для полегшення процесу одужання +
- В. Пояснення щодо особливостей тренування загальної фізичної підготовки та інтеграції в спорт вищих досягнень
- С. Пояснення важливості силових тренувань через біль і втому для вдосконалення фізичних функцій
- Д. Пояснення щодо медикаментів і важливості медикаментозної підтримки
- Е. Надання психоемоційної підтримки та психологічного супроводу

42. Фізичний терапевт проводить навантажувальний тест (тредміл-тест) для пацієнта на етапі амбулаторної реабілітації. Протокол передбачає поступове збільшення інтенсивності кожні 3 хв. Отримано такі дані моніторингу — у спокої: ЧСС — 72/хв, АТ — 120/80 мм рт. ст.; 3-тя хвилина (1-й ступінь): ЧСС — 95/хв, АТ — 135/82 мм рт. ст., 6-та хвилина (2-й ступінь): ЧСС — 118/хв, АТ — 115/80 мм рт. ст. Пацієнт скаржиться на помірну втому, задишка за шкалою Борга — 3 бали (помірна). Яка дія фізичного терапевта є доцільною в цьому разі?

- А. Продовжити тестування, але ретельно моніторити сатурацію кисню (SpO₂), оскільки зниження АТ є допустимим фізіологічним явищем при аеробному навантаженні
- В. Зменшити швидкість тредмілу та запропонувати пацієнту випити води, розцінивши реакцію як ознаку дегідратації
- С. Продовжити тестування на поточному рівні навантаження (без підвищення), оскільки зниження тиску пов'язане зі зменшенням периферичного опору судин (вазодилатацією)
- Д. Збільшити кут нахилу тредмілу, щоб стимулювати роботу серця та підвищити систолічний тиск до адекватних значень
- Е. негайно припинити тестування та перевести пацієнта в положення лежачи або сидячи, оскільки спостерігається гіпотензія навантаження +

43. Пацієнт віком 42 роки після перенесеного інфаркту мозочка з вираженим атактичним синдромом, збереженою силою м'язів проходить підгострий період реабілітації. Вставання та стояння біля опори, ходьба (кілька кроків) відбуваються зі значною підтримкою двох осіб. Який допоміжний засіб

пересування є оптимальним для навчання пацієнта самостійної ходьби на цьому етапі реабілітації?

- A. Милиці пахвові
- B. Палиці для скандинавської ходьби
- C. Ортези на гомілковостопні суглоби
- D. Ходунки +
- E. Чотирьохопорна тростина

44. Пацієнт віком 52 роки після перенесеної пневмонії перебуває в підгострому періоді реабілітації. Скаржиться на задишку під час ходьби та швидку втомлюваність. Під час первинного огляду фізичний терапевт проводить спірометрію для визначення життєвої ємності легень. Пацієнт виконав три спроби повільного повного видиху після максимального вдиху, але одна з них була проведена з кашлем у перші секунди, а друга — з недостатнім зусиллям. Лише третя спроба візуально виглядає якісною. Яка тактика фізичного терапевта буде доцільною в цьому разі?

- A. Відкласти проведення спірометрії на інший день і завершити оцінку легень за допомогою аускультатії та сатурації
- B. Використати для інтерпретації середнє значення всіх трьох спроб, незважаючи на їхню якість, оскільки це «усереднює» стан функції дихання
- C. Прийняти одну якісну спробу як достатню, адже пацієнт перебуває у стані втоми після пневмонії, і подальші повтори можуть погіршити його самопочуття
- D. Інтерпретувати найкращу спробу, навіть якщо вона єдина якісна, але при цьому додати до висновку примітку про неповне виконання маневру
- E. Попросити пацієнта виконати додаткові спроби, щоб було мінімум 2 якісні спроби, і лише після цього інтерпретувати показники +

45. Пацієнт скаржиться на сильний біль у лівій гомілці та стопі під час ходьби. Об'єктивно спостерігається: ціаноз шкіри стопи. Лівою ногою пацієнт не може стояти на пальцях, зникла чутливість на задній поверхні гомілки та підошві. Який нерв, найімовірніше, уражений у пацієнта?

- A. Стегновий
- B. Великогомільковий +
- C. Затульний
- D. Сідничний

Е. Малогомільковий

46. Пацієнт з гострим больовим синдромом у поперековому відділі потрапляє до реабілітаційного відділення на стаціонарну реабілітацію. На якому етапі мультидисциплінарна команда повинна розпочинати планування виписки пацієнта?

- A. Після завершення всіх запланованих реабілітаційних втручань +
- B.
- C. У день виписки пацієнта
- D. З моменту госпіталізації та проведення первинного обстеження
- E. За 3 дні до очікуваної дати завершення лікування

47. У трирічної дитини під час огляду виявлено: знижений тонус м'язів тулуба, труднощі у збереженні стабільної пози під час ігор у положенні сидячи та стоячи, а також часті втрати рівноваги під час рухових активностей. Батьки зазначають, що дитині складно утримувати стійке положення під час ходьби з іграшками або під час переходів між положеннями. Укажіть доцільний компонент фізичної терапії для цієї дитини.

- A. Тренування стійких статичних положень у положенні сидячи
- B. Виконання швидких циклічних рухів, таких як біг
- C. Використання зовнішньої фіксації тулуба протягом активності
- D. Застосування силових вправ із підвищеним опором
- E. Використання сенсорних підходів для розвитку постурального контролю +

48. Пацієнт з наслідками черепно-мозкової травми — однобічною вестибулярною дисфункцією, має виражене запаморочення при швидких рухах голови. Яке втручання є оптимальним на початку вестибулярної реабілітації такого пацієнта?

- A. Вправи на нестабільних платформах
- B. Ходьба на доріжці з обтяжувачами
- C. Обмеження рухів голови на 2-3 тижні
- D. Мануальні техніки шийного відділу
- E. Вправи на стабілізацію погляду +

49. Пацієнт має підозру на пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Який тест найоб'єктивніше підтвердить її пошкодження?

- A. Ромберга
- B. Вальгуса
- C. Лахмана +
- D. Тренделенбурга
- E. Еплі

50. Визначте метод, який застосовується в передчасно народжених немовлят із моменту народження та об'єктивно впливає на регуляцію серцебиття та дихання, підтримку температури тіла, покращення набору ваги.

- A. Метод сухої імерсії
- B. Трансферинг
- C. Позиціонування
- D. Хендлінг
- E. Мама-кенгуру +

51. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на зниження сили м'язів лівої кисті. Із анамнезу відомо, що 4 місяці тому після попадання ракети в будівлю пацієнту уламками затисло кінцівку в ділянці плеча. За цей час сила м'язів збільшилася, але відновилася не повністю. Під час об'єктивного обстеження встановлено, що пацієнт може рухати пальцями кисті, але сила м'язів знижена до 4/5 балів за ММТ. Який вид пошкодження периферичних нервів, найімовірніше, спостерігається в пацієнта?

- A. Невротмезис
- B. Невропраксія
- C. Перерізання
- D. Аксонотмезис +
- E. Розтягнення

52. Жінка віком 25 років під час гри в баскетбол отримала травму — підвивих зап'ястя. Після зняття іммобілізації за направленням лікаря звернулася на консультацію до фізичного терапевта. Під час об'єктивного обстеження спостерігається набряк та обмеження амплітуди рухів у кисті. Який підхід у менеджменті фізичної терапії травми потрібно обрати в цьому разі?

- A. Активні вправи в безболісному діапазоні рухів і контроль набряку +
- B. Робота над покращенням швидкості рухів кисті

C.

D. Знеболювальні препарати та пасивні вправи з максимальним діапазоном руху

E. Імобілізація травмованої ділянки після тренування

53. Новонародженій дитині діагностовано правобічну вроджену м'язову кривошию. На що треба спрямувати заходи фізичної терапії в цьому разі?

A. Розслаблення трапецієподібних м'язів з обох боків та стимуляцію груднино-ключично-соскоподібного м'яза з правого боку

B. Розтягування груднино-ключично-соскоподібного та трапецієподібного м'язів із правого боку, стимуляцію симетричних рухів +

C. Стимуляцію груднино-ключично-соскоподібного м'яза з лівого боку та стимуляцію трапецієподібного м'яза з правого боку

D. Розтягування груднино-ключично-соскоподібного м'яза з правого боку, стимуляцію трапецієподібного м'яза з лівого боку

E. Стимуляцію груднино-ключично-соскоподібних м'язів із правого та лівого боків, стимуляцію трапецієподібних м'язів з обох боків

54. Фізичний терапевт розробляє програму кардіореабілітації пацієнту віком 48 років після гострого інфаркту міокарда та призначає аеробні тренування помірної інтенсивності за формулою резерву серцевого ритму Карвонена з урахуванням результатів тесту з навантаженням: максимальна ЧСС — 170/хв, ЧСС у стані спокою — 70/хв. Яка цільова зона частоти серцевих скорочень відповідає помірній інтенсивності (40-60% від резерву ЧСС)?

A. 120-140/хв

B. Понад 140/хв

C. 90-119/хв

D. 110-130/хв +

E. 136-153/хв

55. Із яких вправ може складатися активна корекція хребта пацієнта з діагнозом: правосторонній грудний сколіоз?

A. Підйом руки вгору з боку випуклості дуги викривлення та нахил ліворуч

B. Підйом руки вгору з боку увігнутості дуги викривлення та нахил праворуч +

C. Нахил назад із ротацією в бік дуги викривлення

D. Відведення руки вбік до горизонталі з боку увігнутості дуги викривлення

Е. Нахил вперед із відведенням прямої руки

56. Синдром неглекту характерний для осіб із гострим порушенням мозкового кровообігу. У якій частині головного мозку локалізована зона ураження?

А. Лобовій

В. Потиличній

С. Тім'яній +

Д. Скроневій

Е. Тім'яно-потиличній

57. Пацієнт віком 60 років, 10 днів після тотального ендопротезування конінного суглоба, перебуває в реабілітаційному відділенні. Під час функціонального обстеження фізичний терапевт оцінює активне згинання до 85° і розгинання до 5°. Пацієнт здатний стояти з частковою опорою на оперовану ногу. Яке із нижченаведених реабілітаційних втручань є найбільш доцільним на цьому етапі?

А. Активні вправи в повному обсязі руху

В. Активна мобілізація суглоба, згинання до 90°, ізометричні вправи, тренування ходьби з милицями +

С. Активне згинання в коліні до 120°, хода з милицями з осьовим навантаженням 30% на прооперовану кінцівку

Д. Виконання присідань і випадів для пришвидшення зміцнення квадрицепса

Е. Повна іммобілізація кінцівки для уникнення зсуву протеза

58. У відділення реабілітації доставлено пацієнта віком 62 роки із діабетичною полінейропатією, який скаржиться на нестійкість під час ходьби, труднощі при вставанні з крісла та страх втратити рівновагу. Фізичний терапевт перед призначенням реабілітаційних втручань оцінює здатність пацієнта підтримувати баланс у різних функціональних положеннях. На який ключовий принцип проведення тесту балансу Берг варто звернути увагу під час обстеження цього пацієнта?

А. Забезпечити безпеку пацієнта, бути поряд під час виконання завдань без фізичної допомоги, надаючи лише вербальні інструкції для уникнення впливу на результат +

- В. Дозволити пацієнту виконувати завдання, тримаючись за поручень, якщо він відчуває невпевненість, щоб уникнути падіння
- С. Виконувати тест із додатковою підтримкою ззаду або збоку, якщо помітні значні порушення рівноваги, щоб пацієнт міг завершити усі 14 завдань
- Д. Дозволити пацієнту виконувати кожне завдання кілька разів і вибрати найкращий результат, щоб отримати найточнішу картину балансу
- Е. Проводити тест у зменшеній модифікації, виключивши вправи з підняттям ніг та нахилами, щоб мінімізувати ризик погіршення стану

59. На скільки сантиметрів змінюється відстань між остистими відростками під час проведення проби Отта в нормі?

- А. Збільшується на 3-4 см +
- В. Зменшується на 1 см
- С. Збільшується на 8-9 см
- Д. Збільшується на 0,5 см
- Е. Зменшується на 12 см

60. У жінки віком 50 років закритий перелом правої променевої кістки (повний, без зміщення). Під час огляду в післяімобілізаційний період виявлено контрактуру ліктьового суглоба. З метою комплексного відновлення пацієнтка отримала направлення до реабілітаційного центру. Яку комбінацію відновних факторів фізичний терапевт має порекомендувати жінці?

- А. Пасивні вправи для плечового суглоба, магнітотерапія, йодовані ванни
- В. Динамічні вправи для згиначів плеча, загальний масаж, озокерит на ділянку зрощення
- С. Спеціальні вправи на покращення розгинання в ліктьовому суглобі, загальне УФО, електрофорез кальцію хлориду +
- Д. Ранкова гімнастика, масаж травмованої кінцівки, парафін на ділянку зрощення
- Е. Циркулярний душ, масаж травмованої кінцівки, парафін на ділянку зрощення

61. Під час обстеження грудної клітки пацієнта з задишкою фізичний терапевт виявляє таку тріаду симптомів над лівою нижньою частиною легені: тупий звук при перкусії, різко ослаблене або відсутнє голосове тремтіння та відсутнє дихання під час аускультатії. Яка патологія, найімовірніше, відповідає цій клінічній картині?

- А. Ателектаз

В. Плевральний випіт +

С. Пневмоторакс

Д. Емфізема

Е. Консолідація

62. Для пацієнта віком 50 років із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) в анамнезі вже протягом кількох років фізичний терапевт розробляє програму фізичної активності, яка допоможе зменшити симптоми рефлюксу. До цієї програми увійшли дихальні вправи. Які дихальні вправи є найкращими для пацієнта з ГЕРХ?

А. На швидке глибоке дихання

В. Із затримкою дихання понад 15 с

С. Дихання через рот

Д. На черевне дихання +

Е. На поверхнєве грудне дихання

63. У пацієнта внаслідок використання пахових милиць розвинулася невропатія довгого грудного нерва. Під час огляду виявлено: синдром крилоподібної лопатки, обмеження відведення плеча понад 90°. Функцію якого м'яза буде порушено у цьому разі?

А. Дельтоподібного

В. Підкісного

С. Переднього зубчастого +

Д. Малого круглого

Е. Трапецієподібного

64. До реабілітаційного центру звернувся чоловік віком 43 роки для легеневої реабілітації після COVID-19. Який симптом є «жовтим прапорцем» і вимагає залучення інших медичних працівників, окрім фахівців з реабілітації?

А. ЧСС — 85/хв

В. Посттравматичний стресовий розлад +

С. ЧД — 20/хв

Д. АТ — 130/80 мм рт. ст.

Е. Підвищення температури тіла до 37°C

65. Пацієнт віком 58 років з погано компенсованим цукровим діабетом 2-го типу скаржиться на біль та поколювання в стопах. Об'єктивно виявлено: зниження вібраційної чутливості на рівні гомілковостопних суглобів та сили м'язів-згиначів стопи, при ході — опускання стопи. Який захід фізичної терапії є патогенетично обґрунтованим на цьому етапі реабілітації?

- A. Силкові вправи на тренажерах для нижніх кінцівок
- B. Електростимуляція м'язів передньої поверхні гомілки та стоп
- C. Масаж нижніх кінцівок за класичною методикою
- D. Тренування ходи з ортезом та правильного перекатування стопи +
- E. Кінезіотейпування литкових м'язів

66. Яку тактику необхідно використати для лікування пацієнта з правобічним спастичним геміпарезом зі збереженими селективними рухами пальців і кисті, щоб уникнути «навченого невикористання» верхньої кінцівки?

- A. Розвиток координаторних якостей верхньої кінцівки
- B. Кінезіотерапія, вправи на амплутуду рух
- C. Посилення тренування/використання ураженої руки
- D. Вправи на силу та координацію м'язів ураженої кінцівки
- E. Обмеження неушкодженої руки та посилення тренування/використання ураженої руки +

67. Пацієнт віком 32 роки із встановленим діагнозом: анкілозуючий спондиліт, скаржиться на вранішню скутість та нічний біль у попереково-крижовому відділі хребта. Пацієнт проходить курс амбулаторної реабілітації. Фізичний терапевт підбирає оптимальне реабілітаційне втручання та визначає спосіб контролю його ефективності. Який варіант буде найбільш обґрунтованим?

- A. Вправи на мобілізацію хребта та контроль за допомогою тесту Шобера +
- B. Заняття на біговій доріжці у швидкому темпі та контроль за допомогою сатурації
- C. Застосування теплових процедур на поперековий відділ та контроль рівня болю за шкалою ВАШ
- D. Витягіння хребта та контроль рівня артеріального тиску
- E. Силкові тренування та контроль ефективності шляхом вимірювання частоти серцевих скорочень

68. Чоловік віком 46 років скаржиться на задишку, яка з'являлася спочатку при навантаженні, а потім і в стані спокою, хронічний кашель з невеликою кількістю мокротиння, відчуття дискомфорту в грудях. Який симптом є доказом емфіземи легень, оскільки полегшує дихання внаслідок створення позитивного тиску в кінці видиху?

- A. Дихання з максимальною затримкою після вдиху
- B. Дихання з опором через стиснуті губи
- C. Переривчасте дихання
- D. Гучний форсований вдих
- E. Дихання із затримками на видиху +

69. Під час тестування фізичним терапевтом чоловіка віком 80 років виявлено, що пацієнту складно сконцентруватися та зрозуміти поточну ситуацію, є проблеми з пам'яттю та іншими когнітивними здібностями. Для якого захворювання характерні такі клінічні показники?

- A. Деадаптації
- B. Депривації
- C. Деменції +
- D. Хвороби Паркінсона
- E. Гострого порушення мозкового кровообігу

70. Пацієнт після тяжкої черепно-мозкової травми має потьмарення свідомості. Реагує на дотик і знайомий голос, але не виконує команд. Який напрямок втручання є пріоритетним на цьому етапі?

- A. —
- B. Тренування постурального контролю сидячи
- C. Сенсорна стимуляція тандемними стимулами +
- D. Тренування концентрації уваги
- E. Активна мобілізація кінцівок

71. Пацієнтка віком 27 років перебуває на стаціонарному лікуванні з діагнозом: гостра лівобічна нижньочасткова пневмонія. Укажіть положення тіла, яке необхідно прийняти пацієнтці під час виконання статичного постурального дренажу.

- A. Лежачи на лівому боці, з валиком під тазом і під нижньою частиною грудної клітки, частина ліжка з боку ніг піднята на 30-40 см
- B. Лежачи на лівому боці, частина ліжка з боку голови піднята на 30 см
- C. Лежачи на правому боці, частина ліжка з боку голови піднята на 30 см
- D. Сидячи, трохи нахилитися вперед і вправо
- E. Лежачи на правому боці, з валиком під тазом і під нижньою частиною грудної клітки, частина ліжка з боку ніг піднята на 30-40 см +

72. У чоловіка віком 52 роки на 6-й день після тотального ендопротезування правого кульшового суглоба стан задовільний, ускладнень не виявлено, ранню фізичну терапію розпочато в 1-й день після операції. Яка вправа допоможе розширити руховий режим пацієнта на 8-й день у разі такого перебігу післяопераційного періоду?

- A. Тренування ходьби сходами із милицями +
- B. Тренування ходьби з підлікотними милицями
- C. Тренування переходу з положення сидячи в положення стоячи
- D. Тренування ходьби сходами без милиць
- E. Тренування стояння з підлікотною милицею

73. Пацієнт віком 40 років, військовослужбовець, після отримання мінно-вибухового поранення та ампутації лівої верхньої кінцівки на рівні передпліччя скаржиться на пекучий біль високої інтенсивності в пальцях лівої верхньої кінцівки, за шкалою ВАШ — 7-8 балів, що не тамується середньодобовими дозами знеболювального. Який вид болю, найімовірніше, спостерігається в пацієнта?

- A. Ноципластичний
- B. Міофасціальний
- C. Запальний
- D. Ішемічний
- E. Фантомний +

74. Який тест із нижчезазначених оцінює індекс ураження щодо різних видів діяльності та призначений для оцінки рухової функції, рівноваги, чутливості й функціонування суглобів у пацієнтів із постсультною геміплегією?

- A. Фугл-Мейєра +

- B. Френчай
- C. Із дев'ятьма лунками та кілочками
- D. Берг
- E. Викреслювання ліній

75. Фізичний терапевт обстежує пацієнта на 14-й день після інсульту. За шкалою PASS (Postural Assessment Scale for Stroke Patients) пацієнт набирає 32 бали (з 36). Який прогноз та план виписки є найбільш імовірними для пацієнта, зважаючи на цей бал?

- A. Пересування лише з ходунками та потреба у сторонній допомозі при вставанні
- B. Прогноз неможливо визначити лише за шкалою PASS, необхідно провести тест TUG
- C. Є потреба у кріслі колісному та, імовірно, необхідність переводу до закладу тривалого догляду
- D. Висока ймовірність відновлення незалежної ходи (>90%) та, імовірно, подальша рекомендація до виписки додому +
- E. Високий ризик падінь, але є можливість виписки додому під цілодобовий нагляд

76. Фізичну працездатність пацієнтів, які хворіють на бронхіальну астму, оцінюють шляхом індивідуальної можливості витримувати фізичне навантаження. Який метод застосовують у цьому разі?

- A. Спірографію
- B. Спірометрію
- C. Велоергометрію +
- D. Стрельнікової
- E. Бутейка

77. Пацієнту із жовчно-кам'яною хворобою призначено фізичну терапію. Які терапевтичні вправи насамперед сприятимуть покращенню обміну речовин і стимуляції жовчовиділення?

- A. Дихальні, на скручування, нахили вперед +
- B. Для черевного пресу, на баланс, присідання
- C. Дихальні, для черевного пресу, на розтяг задньої поверхні стегна
- D. Підйом ніг лежачи на спині, на баланс і підтримку рівноваги

Е. Підйом ніг лежачи на спині, гіперекстензія, присідання з гантелями

78. До фізичного терапевта звернувся пацієнт віком 45 років зі скаргами на хронічний біль у поперековому відділі хребта, що триває понад 3 місяці.

Пацієнт зазначає, що біль суттєво обмежує його повсякденну активність: він не може піднімати важкі предмети, відчуває труднощі при тривалому сидінні (понад 15 хв) та має порушення сну через дискомфорт. Фахівцю необхідно об'єктивізувати вплив болю на повсякденне функціонування пацієнта для оцінки ефективності майбутнього втручання. Який із нижченаведених інструментів є міжнародно визнаним «золотим стандартом» для специфічної оцінки ступеня порушення життєдіяльності саме в цієї категорії пацієнтів?

- А. Короткий опитувальник болю МакГілла
- В. Опитувальник інвалідності Освестрі +
- С. Загальний опитувальник здоров'я SF-36
- Д. Шкала тривоги та депресії HADS
- Е. Візуально-аналогова шкала

79. Пацієнтка віком 62 роки проходить реабілітацію з діагнозом: двобічний гонартроз II ст. Скаржиться на біль у колінних суглобах під час ходьби та після тривалого стояння, біль посилюється при спусканні сходами та після фізичного навантаження. Фізичний терапевт підбирає програму фізичної терапії, спрямовану на зменшення болю та покращення функції колінних суглобів. Яке реабілітаційне втручання та метод контролю ефективності реабілітації є найбільш доцільними у цьому разі?

- А. Масаж спини та нижніх кінцівок із контролем ефективності за допомогою добового моніторингу артеріального тиску
- В. Виконання силових вправ і контроль ефективності за частотою серцевих скорочень
- С. Виконання вправ на зміцнення м'язів стегна з контролем ефективності за допомогою шкали WOMAC +
- Д. Використання ортезів для колінних суглобів та контроль ефективності за шкалою ВАШ
- Е. Застосування теплових процедур з контролем ефективності за показниками сатурації

80. Кукса характеризується такими показниками: зниженою функцією м'язів, болючістю під час пальпації, нестійкістю об'ємних розмірів, має атрофічні в'ялі тканини, на торцевих поверхнях яких можуть бути трофічні розлади

шкіри без запальних явищ. Кукса може призвести до згинальної або розгинальної контрактури суміжного суглоба, помірної вираженої неспроможності зв'язок суглоба, довжина кукси недостатня для керування протезом (коротка кукса). Укажіть цей вид кукси.

- A. —
- B. Довга
- C. Функціональна
- D. Малофункціональна +
- E. Нефункціональна

81. Фізичний терапевт складає програму реабілітації для мотивованого пацієнта віком 62 роки з правобічним геміпарезом і порушенням рівноваги після ішемічного інсульту з метою відновлення ходьби з мінімальною допомогою та повернення до самообслуговування. Що з нижченаведеного є сприятливим фактором навколишнього середовища для особи, яка відновлюється після інсульту?

- A. Високий поріг при вході до квартири
- B. Відсутність пандуса при вході до під'їзду
- C. Нековзний килимок у ванній кімнаті +
- D. Відсутність медичної страховки
- E. Негативне ставлення сусідів

82. У десятимісячної дитини (скоригований вік) під час огляду виявлено недостатній контроль тулуба в положенні сидючи: дитина нестабільно нахиляється вперед або вбік і не може зберігати положення сидючи під час взаємодії з іграшками. Укажіть доцільний компонент фізичної терапії в цьому разі.

- A. Використання обтяжень для тренування м'язів тулуба
- B. Тренування стрибків з підтримкою
- C. Орієнтація на вертикалізацію в положенні стоячи
- D. Використання позиційного тренування на підлозі з акцентом на опорні реакції +
- E. Тренування ходи з опорою в ходунках

83. Пацієнтка віком 62 роки звернулася до фізичного терапевта зі скаргами на хронічний біль у попереку, що триває 8 місяців. Біль є постійним, не

зменшується в положенні лежачи, посилюється вночі та не полегшується при зміні положення тіла. В анамнезі відсутня травма. Пацієнтка повідомляє про немотивовану втрату маси тіла (7 кг за 6 місяців), постійну втому та загальну слабкість. Який висновок є найбільш обґрунтованим на основі цих суб'єктивних даних і які дії фізичного терапевта є пріоритетними?

- A. Наявні «червоні прапорці», що можуть вказувати на серйозну системну патологію, необхідно негайно скерувати пацієнтку до лікаря +
- B. Зареєструвати пацієнтку з неспецифічним болем у попереку та застосувати інструменти для оцінки жовтих прапорців, оскільки біль має ознаки хронізації
- C. Біль має запальний характер, рекомендовано поступове збільшення фізичної активності
- D. Біль має механічний характер, варто розпочати програму вправ на стабілізацію тулуба
- E. Спрямувати обстеження на виключення радикулопатії, оскільки постійний нічний біль часто асоціюється із здавленням нервового корінця

84. Під час обстеження чотиримісячної дитини щодо підвищеного тону м'язів фізичним терапевтом використано тест для оцінки ризику розвитку церебрального паралічу, що включає неврологічне обстеження, оцінку розвитку моторних функцій та поведінку. Який тест використав фізичний терапевт у цьому разі?

- A. HINE +
- B. AIMS
- C. PEDI
- D. GMFCS
- E. Ашворта

85. З якою метою виконуються пасивні вправи на розтяг м'язів у пацієнтів зі спастичністю, що викликана травмою чи захворюванням центральної нервової системи?

- A. Для тренування сили м'язів
- B. Для венозного відтоку в спазмованих м'язах
- C. Для формування рухових навичок
- D. Для профілактики контрактур +
- E. Для зменшення спастичності та тону м'язів

86. Чоловік віком 48 років скаржиться на біль та обмеження амплітуди розгинання в поперековій ділянці хребта. Ознак червоних та жовтих прапорців не виявлено. Які вправи порекомендує фізичний терапевт пацієнту?

- A. На розгинання м'язів поперекового відділу хребта
- B. На розтягнення м'язів поперекового відділу хребта +
- C. З нахилом тулуба вперед до 15-20°
- D. Нахили тулуба вперед до 45°
- E. Статичні для м'язів живота

87. До фізичного терапевта звернувся професійний волейболіст з діагнозом: пошкодження сухожилка надостового м'яза. Фахівець визначає, що для досягнення терапевтичного ефекту пацієнт повинен на 4 тижні відмовитися від професійних активностей. Проте пацієнт зазначив, що потребує прискорення реабілітації у зв'язку з важливими змаганнями за 3 тижні. Фізичний терапевт скорегував плани терапії відповідно до зазначених пацієнтом термінів. Який тип клінічного мислення проявив фізичний терапевт під час прийняття рішення?

- A. Діагностичний
- B. Інтерактивний +
- C. Наративний
- D. Процедуральний
- E. Етичний

88. Пацієнт перебуває у відділенні фізичної та реабілітаційної медицини з травмою спинного мозку на рівні T8. Встановлено нижній парапарез, ASIA C. Що з нижченаведеного є критерієм завершення післягострого реабілітаційного періоду?

- A. Нейрохірургічна стабілізація хребта
- B. Здатність самотійно стояти
- C. Відновлення здатності до самообслуговування
- D. Здатність самотійно сидіти
- E. Здатність до самотійного переміщення з допомогою технічних засобів +

89. П'ятирічному хлопчику встановлено діагноз: ДЦП, Gross Motor Function Classification System (GMFCS) рівень 2. Який інструмент найінформативніше дозволить оцінити порушення статичного та динамічного балансу дитини?

- A. 6-хвилинний тест ходьби
- B. Педіатрична шкала рівноваги +
- C. 10-хвилинний тест ходьби з навантаженням
- D. —
- E. Тест «Встань і йди»

90. Жінка віком 75 років 2 тижні перебуває на витяжці у зв'язку з діафізарним переломом лівого стегна. Їй рекомендована фізична терапія. Яка мета фізичної терапії для цієї пацієнтки?

- A. Збільшення щільності кісткової маси та покращення функціональної здатності м'язів
- B. Відновлення амплітуди руху в колінному суглобі
- C. Відновлення силових показників м'язів нижніх кінцівок
- D. Профілактика пролежнів і респіраторних порушень +
- E. Зниження ризику утворення тромбів у ділянці пошкодження

91. Пацієнт віком 52 роки звернувся до фізичного терапевта зі скаргами на біль у правому плечовому суглобі, що триває 3 місяці та посилюється при піднятті руки вгору та заведенні її за спину. Попередній діагноз — імпіджмент-синдром плечового суглоба. Який спеціальний клінічний тест доцільно використати для підтвердження цього діагнозу?

- A. Тест Томпсона (Thompson test)
- B. Тест Лермітта (Lhermitte's sign)
- C. Тест Гокінса-Кеннеді (Hawkins-Kennedy test) +
- D. Тест Ласега
- E. Тест Спіда (Speed's test)

92. Під час занять терапевтичними вправами з пацієнтом після ендопротезування колінного суглоба терапевт поступово збільшує обсяг та амплітуду рухів, інтенсивність навантаження, контролюючи появу болю й втоми. Який принцип втручання реалізується в цьому разі?

- A. Компенсації

- B. Уникнення болю
- C. Функціонального тренування
- D. Прогресування навантаження +
- E. Індивідуалізації

93. Який тест можна застосувати, щоб оцінити здатність пацієнта модифікувати ходьбу, пов'язану з рухом голови, когнітивними завданнями, зміною її швидкості чи перешкод?

- A. Тест Тінетті
- B. 6-хвилинний тест ходьби
- C. —
- D. 10-метровий тест ходьби
- E. Динамічний індекс ходьби +

94. Пацієнт із хворобою Паркінсона проходить реабілітацію. Який вид групових занять сприятиме підвищенню емоційного статусу й комунікативних можливостей і найбільш підходить для покращення балансу та уникнення епізодів «заморожування» у таких пацієнтів?

- A. Арттерапія
- B. Мануальна терапія
- C. Музикотерапія
- D. Танцетерапія +
- E. Терапевтичні вправи

95. У немовляти, народженого на 32-му тижні гестації, під час планового огляду у віці 5 місяців (скоригований вік 3 місяці) відзначаються задовільне самопочуття, адекватні раціон вигодовування та очікувані для віку рухові реакції. Фахівець з реабілітації має оцінити фізичний розвиток дитини відповідно до чинних стандартів спостереження за передчасно народженими дітьми. За якими показниками необхідно проводити оцінювання фізичного розвитку в цьому разі?

- A. За антропометричними показниками +
- B. За показниками м'язового тону
- C. За показниками прояву реакцій рівноваги

- D. За показниками прояву набутих рефлексів
- E. За показниками прояву вроджених рефлексів та їх редукції

96. Яку мету відповідно до принципу SMART можна вважати короткотривалою для пацієнта зі спинномозковою травмою в гострому реабілітаційному періоді?

- A. Самостійна купівля пляшки води
- B. Участь у місцевому адаптивному спортивному заході
- C. Досягнення повної незалежності в догляді за сечовим міхуром і кишечником
- D. Регулярна участь у громадських заходах
- E. Опанування техніки переміщення з ліжка на візок і навпаки +

97. Пацієнт віком 32 роки через 3 місяці після повного травматичного ураження спинного мозку на рівні Th6 через 15 хв від початку навчання переміщенню з ліжка на крісло колісне раптово поскаржився на сильний пульсуючий головний біль, нечіткість зору та тривогу. Об'єктивно спостерігається: рясне потовиділення та почервоніння шкіри обличчя та шиї, бліда та холодна шкіра нижче рівня ураження, АТ — 170/100 мм рт. ст., пульс — 52/хв. Який стан, що розвинувся в пацієнта, є першочерговою підставою для негайного припинення вправи та модифікації втручання?

- A. Панічна атака
- B. Синдром гіперсимпатикотонії
- C. Ортостатична гіпотензія
- D. Гіпертензивний криз
- E. Автономна дисрефлексія +

98. Пацієнт із ХОЗЛ виконує вправи на велоергометрі. На початку сатурація кисню (SpO2) становила 94%. На 5-ій хвилині навантаження SpO2 падає до 87%, пацієнт скаржиться на задишку 6/10 за шкалою Борга, але наполягає на продовженні. Якою має бути негайна дія фізичного терапевта?

- A. Зменшити інтенсивність навантаження на 50%, попросити пацієнта дихати глибоко та продовжити безперервний моніторинг серцевого ритму
- B. Негайно припинити навантаження, перевести пацієнта в положення «tripod» (з опорою руками) та розпочати дихання через зціплені губи +
- C. Негайно припинити навантаження, покласти пацієнта на кушетку в положення лежачи на спині та виконати техніку форсованого видиху

D. Зробити коротку паузу на 30 с, дати пацієнту випити води та відновити навантаження з меншою інтенсивністю під контролем пульсу

E. Продовжити навантаження без змін, заохотити пацієнта застосувати діафрагмальне дихання та повторно виміряти сатурацію через 2 хв

99. Чоловіку віком 54 роки встановлено діагноз: ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, III ФК. Проходить постстаціонарну фізичну терапію в кардіологічному санаторії. Йому показані аеробні фізичні навантаження. Яку форму і дозу аеробного навантаження має призначити фізичний терапевт відповідно до функціонального класу, на початку проведення санаторного курсу кардіореабілітації?

A. Біг у помірному темпі

B. Дозована ходьба в повільному темпі (70-80 кроків/хв) із зупинками через кожні 100-200 м

C. Дозована ходьба в темпі 90-100 кроків/хв з короткочасним прискоренням по 2-3 хв у темпі 120-130 кроків/хв

D. Дозована ходьба в помірному темпі (110 кроків/хв) з короткочасним прискоренням по 3-5 хв у темпі 120-130 кроків/хв

E. Дозована ходьба в середньому темпі (90 кроків/хв)+

100. На момент виписки пацієнта після інсульту з лівобічним геміпарезом встановлено, що він може рухатися самостійно з тростиною в межах відділення реабілітації під наглядом іншої особи. Фізичний терапевт надав рекомендації щодо безпеки самостійного пересування вдома: прибрати меблі та яскраво маркувати стіни та дверні отвори з лівого боку. Про наявність якого синдрому свідчать надані рекомендації щодо безпеки пацієнта в цьому разі?

A. Гемігіпестезії

B. Неглекту +

C. Апраксії

D. Диплопії

E. Акінезії

101. Постінсультний пацієнт з лівобічним геміпарезом під час вставання та ходьби активно відштовхується від здорового боку, що призводить до порушення балансу та падіння в бік парезу, вирівнюватися відмовляється. Симптоми якого неврологічного розладу виявлено в пацієнта?

A. Атаксії

- В. Неглекту
- С. Геміанопсії
- Д. Пушер-синдрому +
- Е. Гемігіпестезії

102. Яке захворювання характеризується дифузним прогресуючим ураженням бронхіального дерева, що зумовлене тривалим подразненням і запаленням повітроносних шляхів різними шкідливими агентами, проявляється перебудовою секреторного апарату слизової оболонки, розвитком запального процесу та склеротичними змінами в більш глибоких прошарках, супроводжується гіперсекрецією та порушенням очисної функції бронхів?

- А. Плеврит
- В. Хронічний бронхіт +
- С. Пневмонія
- Д. Гострий бронхіт
- Е. Бронхіальна астма

103. Пацієнт віком 42 роки, 6 тижнів після ЧМТ, завершив 4-тижневу індивідуальну програму реабілітації, спрямовану на покращення рівноваги та мобільності. У день виписки фізичний терапевт повторно проводить шкалу Берг та 10-метровий тест, щоб порівняти з початковими даними та оцінити досягнення цілей. Який тип контролю здійснює фізичний терапевт у цьому разі?

- А. Адміністративний
- В. Скринінговий
- С. Підсумковий +
- Д. Етапний
- Е. Попередній

104. Під час обстеження пацієнта віком 70 років через 3 тижні після ішемічного інсульту сума балів за Шкалою балансу Берг (Berg Balance Scale) становила 42 бали. Який клінічний висновок щодо ризику падінь та потреби в допоміжному засобі є найбільш точним?

- А. Оцінка за шкалою Берг не є валідною для прогнозування ризику падінь у пацієнтів після інсульту

- B. Пацієнт має високий ризик падінь і потребує допоміжного засобу для ходьби +
- C. Пацієнт має низький ризик падінь і може пересуватися самостійно без нагляду
- D. Пацієнт повністю залежить від крісла колісного
- E. Пацієнт має помірний ризик падінь, але може пересуватися самостійно в межах квартири

105. Фізичний терапевт підбирає програму втручання для пацієнтки віком 68 років з діагнозом правосторонній гонартроз II стадії (без реактивного синовіту). Пацієнтка скаржиться на постійний ниючий біль у колінних суглобах (5-6 по VAS), який посилюється при ходьбі та спуску сходами, обмеження розгинання в колінному суглобі. Які терапевтичні вправи будуть протипоказані в цьому разі?

- A. Вправи на розтягування м'язів задньої поверхні стегна та литкових м'язів
- B. Згинання та розгинання коліна в положенні сидячи або лежачи
- C. Заняття на велотренажері
- D. Стрибки, біг, глибокі присідання +
- E. Пропріоцептивні та координаційні вправи

106. Чотирнадцятирічна дитина хворіє на ідіопатичний сколіоз. Оберіть оптимальний метод фізичної терапії з погляду доказової медицини для цієї дитини.

- A. Шрот-терапія +
- B. Корекційний масаж
- C. Бальнеотерапія
- D. Мануальна терапія
- E. Терапевтичні вправи

107. Пацієнт скаржиться на пекучий, стріляючий, «схожий на удар струмом» біль у руці, що супроводжується парестезією — «повзанням мурашок» у зоні іннервації ліктьового нерва. Який тип болю є найбільш імовірним?

- A. Ноципластичний біль
- B. Ноцицептивний соматичний біль (глибокий)
- C. Ноцицептивний соматичний біль (поверхневий)
- D. Ноцицептивний вісцеральний біль

Е. Нейропатичний біль +

108. Жінка віком 48 років після черепно-мозкової травми, скаржиться на порушення балансу, невпевненість при ходьбі, похитування, особливо із закритими очима. Під час проби Ромберга виявлено: нестійкість, з відкритими очима стоїть краще. Координаційні проби виконуються неточно, але тремор відсутній. Який тип атаксії спостерігається в жінки?

А. Динамічна

В. Коркова

С. Сенситивна +

Д. Вестибулярна

Е. Мозочкова

109. Пацієнт віком 75 років має вологий (продуктивний) кашель більше ніж 10 років та задишку, що виникає під час фізичного навантаження. Встановлено діагноз: ХОЗЛ. Яке дихання доцільно застосувати для очищення дихальних шляхів від мокротиння та зменшення задишки?

А. —

В. Із негативним тиском на вдиху

С. Із позитивним тиском на вдиху

Д. Із негативним тиском на видиху

Е. Із позитивним тиском на видиху +

110. На огляд до фізичного терапевта батьки привели семирічного хлопця з діагнозом: ДЦП, рівень GMFCS I. Основна скарга батьків: дитина часто перечіпляється під час активних ігор та «гупає» ураженою ногою при ходьбі по школі. Під час відеоаналізу ходи терапевт зафіксував, що дитина здатна виконати початковий контакт п'ятою, але одразу після цього відбувається різке, неконтрольоване падіння переднього відділу стопи на поверхню. Недостатність ексцентричного контролю якого м'яза є причиною такого патерну ходи?

А. Середній сідничний м'яз

В. Задня група м'язів стегна

С. Литковий та камбалоподібний м'язи

Д. Передній великогомілковий м'яз +

Е. Чотириголовий м'яз стегна

111. Чоловік під час ходьби сильно згинає ногу в колінному суглобі, переносячи її вперед, спершу стає на пальці, потім спирається на латеральний край підошви та опускає п'яту. Об'єктивно спостерігається: звисання стопи в позиції підошовного згинання з незначною ротацією до середини, парестезії та каузалгії, знижені ахіловий і підошовний рефлекс, ММТ м'язів дорсальних згиначів стопи — 2 бали, пропріорецептивна чутливість — змінена. Який патологічний процес спостерігається в пацієнта?

А. Невропатія малогомілкового нерва +

В. Гонартроз колінного суглоба

С. Плоскостопість

Д. Поліартрит

Е. Розрив ахілового сухожилля

112. Фізичний терапевт проводить 6-хвилинний тест ходьби чоловіку з порушенням діяльності ССС. Під час тестування пацієнт зупинився та сів на стілець для відпочинку. Які подальші дії фізичного терапевта?

А. Час зупиняється, у протоколі фіксується час відпочинку, після відпочинку пацієнт продовжує тестування

В. Час не зупиняється, фізичний терапевт оцінює життєво важливі показники, у протоколі фіксується час відпочинку, після відпочинку пацієнт продовжує тестування

С. Час не зупиняється, у протоколі фіксується час відпочинку, після відпочинку пацієнт продовжує тестування +

Д. Тест закінчується, фіксується час та підраховується пройдена відстань

Е. Час не зупиняється, фізичний терапевт пропонує продовжити тестування за допомогою допоміжного засобу, у протоколі фіксується час відпочинку

113. Пацієнт віком 24 роки, професійний волейболіст, звернувся до фізичного терапевта через 8 тижнів після оперативного лікування (ORIF - відкрита репозиція з внутрішньою фіксацією) спірального перелому середньої третини правої плечової кістки. Рентгенологічно підтверджено консолідацію перелому. За оцінкою гоніометрії верхньої кінцівки, правої руки: активне згинання плеча — 100°, відведення — 90°, сила м'язів ротаторної манжети — 3/5, відзначається атрофія дельтоподібного м'яза. Пацієнт висловлює сильне занепокоєння щодо своєї кар'єри та запитує, чи зможе він знову виконувати атакуючі удари на професійному рівні. Фізичний терапевт, базуючись на

даних обстеження та біопсихосоціальних факторах, формулює «прогноз». Який саме компонент прогнозу у фізичній терапії безпосередньо описує найвищий рівень функціонування та змін у пацієнта?

- A. Короткострокові цілі
- B. Реабілітаційний потенціал +
- C. Частота та тривалість втручання
- D. Очікувані результати
- E. План виписки

114. Під час обстеження пацієнта виявлено химерні рухи та ходьбу. Пацієнт демонструє рівновагу, але насправді не падає. Яке ймовірне неврологічне порушення ходи спостерігається в пацієнта?

- A. Кульгавість
- B. «Завмираюча хода»
- C. Ходьба у разі запаморочення
- D. Психогенна хода +
- E. Хореотична хода

115. Для ліквідації або зменшення яких контрактур треба використовувати постізометричну релаксацію (ПІР)?

- A. Дерматогенних
- B. Десмогенних
- C. Артрогенних
- D. Міогенних +
- E. Капсулярних

116. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на біль у коліні, що з'явився кілька тижнів тому та посилюється під час фізичних навантажень, зокрема ходьби або піднімання сходами. Зранку пацієнтка відчуває скутість у коліні, яка зникає через деякий час після виконання рухів. Під час об'єктивного обстеження спостерігається невеликий набряк і місцеве підвищення температури. Який механізм болю найімовірніший у цьому разі?

- A. Ішемічний
- B. Нейропатичний

C. Ноципластичний

D. Запальний +

E. Міофасціальний

117. Пацієнту віком 23 роки 2 тижні тому зняли гіпсову іммобілізацію, що була використана у зв'язку з переломом маломілкової кістки в нижній третині. Призначено 30% осьового навантаження на уражену нижню кінцівку. Який із допоміжних засобів пересування найбільш доцільно призначити пацієнту з огляду на найбільшу ефективність щодо відновлення ходьби та безпечність, враховуючи те, що пацієнт планує їх використовувати під час ходьби на вулиці?

A. Милиці +

B. Ходунки

C. Палицю з рухомою опорою

D. Чотирьохопорну палицю

E. Стандартну одноопорну палицю

118. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на тривалий тупий біль у попереку, що посилюється вранці та зменшується після руху. Під час первинного обстеження фізичний терапевт хоче кількісно оцінити інтенсивність болю для подальшого простеження динаміки. Який клінічний інструмент дозволяє оцінити інтенсивність болю?

A. Шкала Борга

B. Модифікована шкала Ренкіна

C. Шкала Берг

D. Візуальна аналогова шкала +

E. Шкала Ранчо Лос Амігос

119. Пацієнт після трансфеморальної ампутації проходить передпротезну реабілітацію. Скаржиться на різні типи болю: періодичний ниючий біль у ділянці кукси, різкі простріли по ходу нерва, епізоди фантомного болю, а також тривогу та труднощі з концентрацією під час больових загострень. Фізичний терапевт планує перед призначенням реабілітаційних втручань провести комплексну оцінку больового синдрому, яка б враховувала сенсорний, афективний та когнітивний компоненти болю. Який інструмент оцінки є найбільш доцільним у цьому разі?

- A. Опитувальник болю Макгілла +
- B. Числова рейтингова шкала
- C. Візуальна аналогова шкала
- D. Опитувальник DN4
- E. Шкала болю за вербалізованими дескрипторами

120. Пацієнту після трансфеморальної ампутації планується виготовлення протезу. Який інструмент обстеження треба використати, щоб спрогнозувати мобільність після ампутації та визначити функціональний рівень активності пацієнта?

- A. Тест чотири квадрати
- B. Функціональне досягання
- C. Amppro
- D. Тест балансу Берг
- E. AmpNoPro +

121. Військовий доставлений до реабілітаційного відділення після черепно-мозкової травми, подвійної ампутації нижніх кінцівок на рівні нижньої третини гомілок. Враховуючи складність випадку, фізичний терапевт вирішив переглянути наукові статті для вибору оптимальної тактики. У пошуковій базі PubMed він знайшов більше ніж 100 досліджень з обраного напрямку. Яке з нижченаведених джерел буде мати найменший рівень доказовості?

- A. Дослідження «Випадок-контроль»
- B. Опис аналогічного клінічного кейсу
- C. Когортне дослідження
- D. Думка провідного фахівця галузі +
- E. Опис серії клінічних випадків

122. Визначте рівень рухових порушень за GMFCS у дванадцятирічної дитини з церебральним паралічем, яка самотійно пересувається в приміщеннях, часом користується тростиною на вулиці для підвищення безпеки, долає сходи, тримаючись за поручні, не здатна бігати чи стрибати та демонструє зниження витривалості під час тривалої ходи.

- A. V
- B. II +

C. I

D. III

E. IV

123. Укажіть рівень ураження спинного мозку, на якому пацієнти з хребетно-спинномозковою травмою потребуватимуть використання ортезів UFO для забезпечення функції ходьби.

A. S2-S4

B. L1-L2

C. L4-S1 +

D. L2-L3

E. L5-S2

124. Пацієнт із перенесеним інсультом, геміпарезом та силою м'язів верхньої кінцівки 1-2 бали скаржиться на помірний біль у плечі паретичної кінцівки. До індивідуальної програми фізичної терапії включено такі втручання, як позиціонування та обережне ставлення до паретичної кінцівки, підтримуючі пов'язки для руки під час переміщення і ходьби пацієнта. Із якою метою зазначені втручання залучені до програми фізичної терапії пацієнта в цьому разі?

A. Підвищення сили м'язів

B. —

C. Зниження спастичності

D. Профілактики сублюксації +

E. Попередження контрактури

125. Пацієнт віком 67 років має застарілий розрив ротаторної манжети (надостного та підостного м'язів). Він не може самостійно підняти руку вище від рівня плеча (активні рухи до 80°), хоча пасивно рука піднімається краще. Тест на розрив позитивний («падаюча рука»). Пацієнт категорично відмовляється від операції. Яку стратегію має застосувати фізичний терапевт, щоб відновити здатність пацієнта піднімати руку вгору?

A. Тривала іммобілізація кінцівки в косинковій пов'язці (4-6 тижнів) для створення умов для спонтанного загоєння розриву

B. Фізичні вправи на зміцнення переднього дельтоподібного м'яза та стабілізаторів лопатки +

С. Ізольовані вправи з високим опором для гіпертрофії надостного м'яза з метою «закриття» дефекту манжети

Д. Фізичні вправи на розтяг капсули суглоба у крайніх амплітудах для збільшення мобільності

Е. Використання тільки пасивних рухів та мобілізації суглоба

126. До реабілітаційного відділення доставлено військового після 8-ої операції з приводу мінно-вибухового поранення. Пацієнт має наслідки ЧМТ, подвійну ампутацію нижніх кінцівок, ампутацію лівої верхньої кінцівки, порушення зору. Складність випадку спонукала фізичного терапевта шукати найбільш валідні методики менеджменту в інтернет-ресурсах. Результатом запиту стала одна публікація (опис клінічного випадку) з незнайомого журналу, що викликало певний сумнів. Якою із запропонованих методик можна оцінити якість отриманого джерела?

А. CRAAP-тест +

В. EndNote

С. PRISMA

Д. PICOT

Е. Mendeley

127. Пацієнтці віком 52 роки проведено ендопротезування колінного суглоба, перебуває в довготривалому періоді реабілітації. Ходить з допомогою тростини, скаржиться на слабкість у ногах, неможливість долати відстань до магазину і назад (близько 500 м в одну сторону). ММТ м'язів нижньої кінцівки 3+/5 балів. Який план втручання буде оптимальним для пацієнтки?

А. Акцент на розтягування м'язів нижньої кінцівки для відновлення повного обсягу рухів без силових тренувань

В. Імобілізація кінцівки для профілактики перевантаження ендопротеза ортезом

С. Проведення інтенсивних вправ на опір із додатковими вагами для швидкого нарощення сили

Д. Короткочасна електроміостимуляція без фізичних вправ, ходьба з поступовим збільшенням дистанції

Е. Прогресивне зміцнення м'язів нижньої кінцівки та аеробні вправи з низьким навантаженням +

128. Яка із нижченаведених реакцій серцево-судинної системи є нормальною під час виконання аеробного навантаження пацієнтом, що раніше переніс інфаркт міокарда?

- A. Підвищення діастолічного артеріального тиску при незмінному систолічному тиску
- B. Зниження діастолічного артеріального тиску при зростанні систолічного тиску +
- C. Зростання частоти серцевих скорочень при незмінному тиску
- D. Зниження систолічного артеріального тиску при незмінній частоті серцевих скорочень
- E. Зниження діастолічного і систолічного артеріального тиску

129. Жінці віком 59 років встановлено діагноз: остеоартрит правого колінного суглоба в стадії загострення. Які спеціальні вправи для ураженої нижньої кінцівки порекомендує фізичний терапевт пацієнтці для виконання в домашніх умовах?

- A. Пасивні на збільшення амплітуди руху
- B. Ізометричні без осьового навантаження +
- C. Статичні з осьовим навантаженням
- D. Ексцентричні з осьовим навантаженням
- E. Активні на збільшення амплітуди руху

130. Пацієнт віком 45 років, працює водієм-далекобійником, скаржиться на біль у поперековому відділі хребта, що іррадіює вниз по лівій нозі, а також відчуття слабкості в стопі. Під час обстеження нижньої кінцівки фізичний терапевт виявив значне зниження м'язової сили (ММТ 2 бали) лише при виконанні пацієнтом розгинання великого пальця стопи. Інші м'язові групи нижньої кінцівки мають нормальну силу. Ураження якого нервового корінця, найімовірніше, відповідає цьому клінічному прояву?

- A. L4
- B. S2
- C. S1
- D. L3
- E. L5+

131. Фізичний терапевт складає програму 24-годинного постурального менеджменту для п'ятирічної дівчинки (ДЦП, спастичний тетрапарез, GMFCS V). Рентгенографія: індекс міграції голівки стегнової кістки (Reimers index) 35% з обох сторін (зона ризику підвивиху). Мета втручання — сприяти правильному формуванню вертлюжної западини та попередити подальшу міграцію. Який режим вертикалізації є науково-обґрунтованим «золотим стандартом» для досягнення цієї структурної мети?

- A. Вертикалізація в коліноупорі з акцентом на повне розгинання колінних суглобів, 20 хв на день, оскільки основним пріоритетом є довжина підколінних м'язів (hamstrings)
- B. Використання крісла колісного з функцією «stand-up» (підйом у положення стоячи) по 10 хв кожен годину для зміни пози, без фіксації кута відведення стегон
- C. Використання переднього опорного вертикалізатора з нейтральним положенням ніг (паралельно одна одній) протягом 30 хв двічі на день
- D. Використання вертикалізатора з розведенням ніг (абдукцією) загалом на 60° (по 30° кожна нога) протягом 60-90 хв щодня +
- E. Пасивні циклічні тренування (мотомед) у положенні сидячи протягом 45 хв щодня замість статичної вертикалізації, оскільки динамічне навантаження краще для кісток

132. На засіданні міськради затверджено положення щодо включення ранньої реабілітації до плану ліквідації можливих наслідків воєнних конфліктів із чітким розподілом функціональних обов'язків фахівців із реабілітації та визначенням реабілітаційних маршрутів. До якого з етапів заходів боротьби зі стихійними лихами та конфліктами належить ця активність?

- A. Пом'якшення наслідків
- B. Реагування
- C. Прогнозування
- D. Відновлення
- E. Готовності +

133. Пацієнтку віком 44 роки доставлено до відділення реанімації 4 год тому з діагнозом: травма грудного відділу хребта, стан після хірургічної стабілізації T7. Що з нижченаведеного має найбільший рівень доказовості щодо профілактики тромбоемболії в цієї пацієнтки?

- A. Рання вертикалізація

- B. Механічна профілактика +
- C. Ранні пасивні рухи в суглобах
- D. Позиціювання тіла
- E. Респіраторна підтримка

134. Під час обстеження дев'ятирічної дівчинки відзначено мимовільні повільні «хробакоподібні» рухи у верхніх кінцівках, гримаси обличчя, змінний тонус м'язів, труднощі при точних рухах. Яку форму ДЦП можна запідозрити в дівчинки?

- A. Подвійну геміплегію
- B. Геміпаретичну
- C. Атаксичну
- D. Спастичну диплегію
- E. Дискінетичну +

135. Дитина 18 місяців скоригованого віку, народжена передчасно на 32 тижні гестації, демонструє нестійкість при стоянні (тримається за опору) та обмежену самостійну ходу з тенденцією до падіння. Під час первинного обстеження виявлено затримку грубої моторики без інших неврологічних симптомів. Використання якого стандартизованого підходу є найбільш доцільним для контролю моторного розвитку на цьому етапі з метою планування реабілітаційної програми?

- A. Мануальне тестування сили як ключовий параметр
- B. HINE для характеристики ранніх функціональних навичок
- C. Оцінити розвиток за допомогою анкети ASQ як основного інструменту
- D. GMFCS як інструмент оцінювання моторного розвитку
- E. GMFM для кількісного аналізу моторних навичок у доменах стояння та ходи +

136. Пацієнт віком 43 роки після перенесеної політравми може ходити, брати та тримати речі однією рукою, але потребує допоміжний засіб для пересування сходами. Який найбільш оптимальний допоміжний засіб можна рекомендувати пацієнту в цьому разі?

- A. Ходунці
- B. Тростина для ходьби +
- C. Милиці пахвові

D. Милиці ліктьові

E. Крісло колісне

137. Під час тестування у вихідному положенні пацієнта лежачи на спині, фізичний терапевт зігнув ліву нижню кінцівку пацієнта в кульшовому суглобі під кутом 45° і в колінному суглобі під кутом 90°. Присівши на стопу лівої нижньої кінцівки, фізичний терапевт захопив ліву гомілку пацієнта за верхню третину, потягнув на себе і встановив зміщення гомілки вперед у колінному суглобі на 7 мм. Яка структура, найімовірніше, пошкоджена в пацієнта в цьому разі?

A. Медіальний меніск

B. Задня хрестоподібна зв'язка

C. Передня хрестоподібна зв'язка +

D. Латеральний меніск

E. Медіальна колатеральна зв'язка

138. Пацієнт із діабетичною нейропатією скаржиться на нестійкість під час ходьби, яка виразно проявляється в темряві та при відволіканні на оточення. Сила м'язів нижніх кінцівок 4/5, рухливість у суглобах збережена. Що визначає причину проблеми пацієнта?

A. Слабкість м'язів стопи

B. Вестибулярна дисфункція

C. Підвищення рівня глюкози в крові

D. Пропріоцептивний дефіцит +

E. —

139. Пацієнт з транстібіальною ампутацією лівої нижньої кінцівки перебуває на ранньому післяопераційному етапі реабілітації. Які реабілітаційні інтервенції є ефективними для контролю набряку, прискорення загоювання кукси та ранньої підготовки до протезування?

A. М'які пов'язки, позиціювання, терапевтичні вправи, масаж

B. М'які пов'язки, менеджмент рубця, терапевтичні вправи, низькочастотна магнітотерапія

C. Жорсткі або напівжорсткі пов'язки, менеджмент рубця, низькочастотна магнітотерапія

D. М'які пов'язки, менеджмент рубця, терапевтичні вправи, масаж

E. Жорсткі або напівжорсткі пов'язки, позиціювання, менеджмент рубця, терапевтичні вправи +

140. Пацієнта віком 28 років після дорожньо-транспортної пригоди доставлено до реанімаційного відділення. Встановлено пошкодження спинного мозку на рівні C8. Стан пацієнта тяжкий, стабільний. Яким є обсяг реабілітаційної допомоги на добу в цьому разі?

A. 3 год +

B. 5 год

C. 2 год

D. 4 год

E. 1 год

141. Пацієнтка віком 46 років звернулася до фізичного терапевта зі скаргами на біль у поперековій ділянці протягом 8 місяців, що посилюється при тривалому сидінні та при нахилах уперед. Обстеження виявило виражене напруження паравертебральних м'язів та слабкість сідничних м'язів. Який режим черезшкірної електричної нервової стимуляції (TENS) фізичний терапевт має обрати для забезпечення знеболення за механізмом «ворітної теорії болю»?

A. Режим TENS з високою частотою (80-120 Hz) та низькою інтенсивністю +

B. Режим TENS з низькою частотою та низькою інтенсивністю

C. Режим TENS з частотою 50 Hz та максимально переносимою інтенсивністю

D. Режим TENS з низькою частотою (2-10 Hz) та високою інтенсивністю

E. Режим інтерференційного струму з частотою 1500-5000 Hz

142. У пацієнта після тяжкого поранення визначається вкорочення нижньої кінцівки. Під час вимірювання загальної довжини і сегментів відмінностей зі здоровою кінцівкою не виявлено. Укажіть тип укорочення пошкодженої кінцівки.

A. Змішане

B. Вкорочення відсутнє

C. Функціональне +

D. Абсолютне

Е. Проекційне

143. Пацієнт віком 60 років 8 місяців тому переніс інфаркт міокарда, має стабільну стенокардію II ФК та супутню ХОЗЛ GOLD II. У клінічному анамнезі перенесений COVID-19 середнього ступеня тяжкості. Останні 2 місяці відзначає зниження толерантності до аеробного навантаження. Фізичний терапевт планує сформувати індивідуальну програму реабілітації. Яке комплексне тестування дозволяє одночасно оцінити функціональний стан серцево-судинної, дихальної і м'язової системи?

- A. 30-секундний тест вставання зі стільця
- B. Кардіореспіраторний тест із фізичним навантаженням +
- C. Тест із 6-хвилинною ходьбою
- D. Тест Купера
- E. Тест «Встань та йди»

144. Пацієнта віком 40 років після іммобілізації нижньої кінцівки скеровано до реабілітаційного відділення. Оцінку якої фізіологічної здатності повинен провести фізичний терапевт перед початком навчання ходьби?

- A. Координації рухів у положенні стоячи
- B. -
- C. Гнучкості в положенні сидючи
- D. Опори на кінцівку в положенні сидючи
- E. Рівноваги в положеннях сидючи та стоячи +

145. Фізичний терапевт навчає пацієнта, який перебуває на післямобілізаційному етапі реабілітації після перелому кісток гомілки, ходьби з тростиною. Який правильний алгоритм пересування пацієнта в цьому разі?

- A. Тростина з боку ураженої кінцівки, переставляє тростину разом зі здоровою ногою, а потім крокує травмованою кінцівкою
- B. Тростина в руці, протилежній до травмованої кінцівки, переставляє тростину та одночасно робить крок травмованою ногою, після цього — крок здоровою ногою +
- C. Тростина в руці, протилежній до травмованої кінцівки, переставляє спочатку тростину, потім робить крок здоровою ногою, потім — травмованою
- D. Тростина з боку ураженої кінцівки, переставляє тростину разом з травмованою ногою, потім — здорову ногу

Е. Тростина в будь-якій руці, як зручно пацієнту, робить крок травмованою кінцівкою при одночасному переносі тростини, потім — крок здоровою ногою

146. Фізичний терапевт проводить обстеження пацієнта віком 16 років з муковісцидозом (тяжкий перебіг, ОФВ1 < 40%). Під час оцінювання техніки виконання маневру... (текст обривається на фотографії)

147. Пацієнтці віком 60 років проведено операцію на кульшовому суглобі. Одним із рекомендованих застережень є не згинати стегно більше ніж на 90°. Який із нижченаведених допоміжних пристроїв є найкориснішим для пацієнтки вдома?

- А. Підставка під стопу при сидінні
- В. Подушка-роздільник колін
- С. Насадка на унітаз +
- Д. Додаткові перила у ванній
- Е. Валік для позиціонування

148. Фізичний терапевт звернув увагу на те, що пацієнт під час ходьби оберігає ногу та спирається на неї обережно. За результатами обстеження встановлено: рівень болю за шкалою ВАШ — 5 балів, тонус м'язів у нормі, причиною обмеження пасивної та активної амплітуди рухів є біль, усі види чутливості збережені, нижні кінцівки — антропометрично-симетричні. Який вид патологічної ходьби спостерігається в цього пацієнта?

- А. Справжня кульгавість
- В. Качина хода
- С. Паралітична хода
- Д. Спастична хода
- Е. Несправжня кульгавість +

149. Пацієнт віком 48 років перебуває в гострому відділенні з діагнозом: ішемічний інсульт у лівій півкулі головного мозку. Скаржиться на слабкість у правих кінцівках, хиткість при ході. Переміщується з допомогою ходунків. Оцінка функціонування та мобільності в повсякденній активності за Індексом Бартела (BI) — 55 балів. Оцініть рівень незалежності пацієнта від сторонньої допомоги.

- А. Повна
- В. Легка

C. Незалежна

D. Помірна +

E. Сильна

150. У пацієнта після черепно-мозкової травми у фазі ходи «початковий контакт» (Initial Contact) спостерігається надмірне плантарне згинання стопи та контакт передньою частиною стопи з поверхнею. Яке обстеження необхідно провести для визначення ймовірної причини рухового порушення для цього пацієнта?

A. Тестування за модифікованою шкалою Ашворта плантарних згиначів стопи +

B. Тестування за модифікованою шкалою Ашворта довгого згинача великого пальця стопи

C. Тестування за модифікованою шкалою Ашворта дорсальних згиначів стопи

D. Тестування за модифікованою шкалою Ашворта заднього великогомілкового м'яза

E. Тестування за модифікованою шкалою Ашворта короткого згинача пальців стопи